

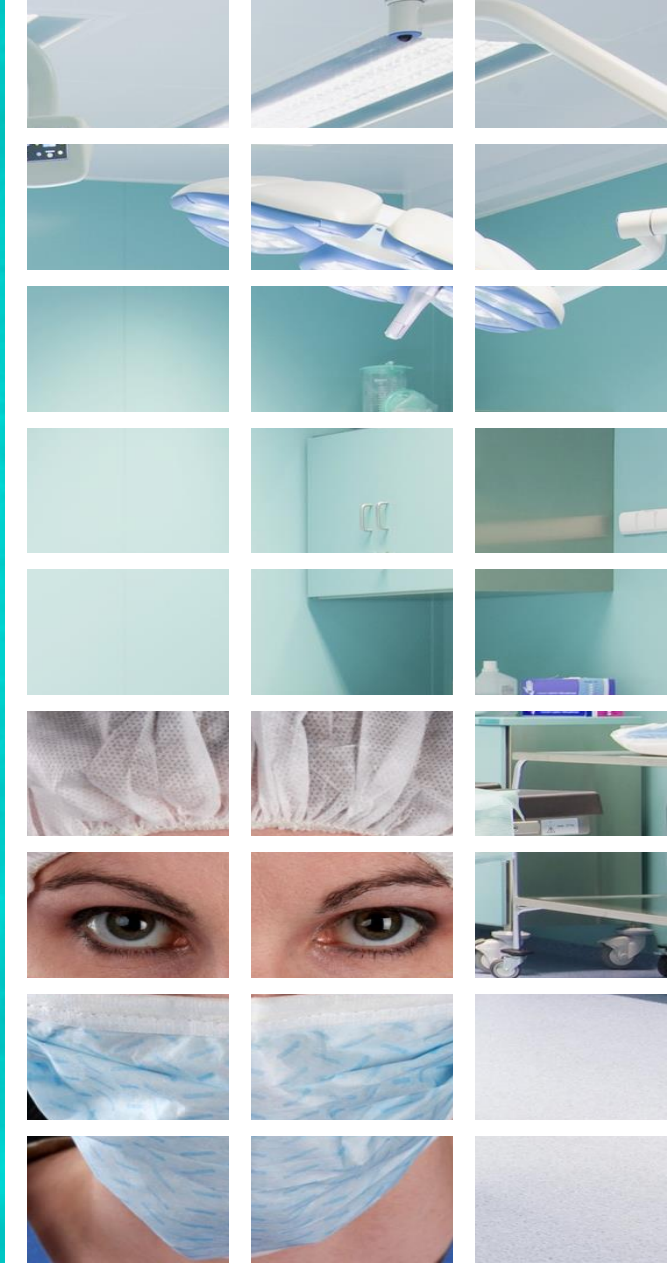
มนทัศน์ทางการพยาบาลปริศลยกรรม

ศ.ดร. อุษาวดี อัศดรวิเศษ

Prof. Dr. Usavadee Asdornwised

Faculty of Nursing, Mahidol University

Bangkok, Thailand



Concepts

- แนวคิดที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุ หรือปรากฏการณ์นั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร
- a mental image of an object or phenomenon
- an idea or an understanding, or a sense about the nature of something
- a word or phrase that labels an abstract but commonly understood object or phenomenon
- ยกตัวอย่างเช่น Pain, Health, Happiness, Recovery

Theories

- ข้อกำหนด ที่ให้ความหมาย อธิบาย หรือให้ลักษณะของปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ
- **A statement that purports to account for or characterize some phenomenon (Barnum, 1990, p. 1)**
- **A set of ideas, hunches or hypotheses that provides some degree of prediction and/or explanation of the world (Dickoff & James, 1968; Chinn & Jacobs, 1987)**

ความหมายของ Conceptual Model

a set of relatively abstract and general concepts that address the phenomena of central interest to a discipline, the propositions that broadly describe those concepts, and the propositions that state relatively abstract and general relations between two or

more of the concepts of the discipline

มโนคติหรือแนวคิดที่ประกอบกันขึ้นในการอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่สนใจสำหรับศาสตร์สาขานั้น ๆ และประกอบไปด้วยข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนคติตั้งแต่ 2 มโนคติขึ้นไปอย่างกว้าง ๆ

มโนทัศน์ทางการพยาบาลปริศัลยกรรม

- **การพยาบาลปริศัลยกรรม (Perioperative Nursing Practice)** เป็นการพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วยในระยะก่อน ระหว่างและหลังผ่าตัด หรือที่มารับหัตถการที่มีการล้วงลำเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย โดยการปฏิบัติการพยาบาลนี้มีความเฉพาะสำหรับห้องผ่าตัด ศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ แบบไม่พักค้าง หรือแบบผู้ป่วยนอก(Ambulatory surgery centers) ห้องสำหรับส่องกล้อง (Endoscopy suites) ศูนย์เลเซอร์ แผนกรังสีร่วมรักษา(มีการทำหัตถการโดยรังสีแพทย์) ห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ หรือ คลินิกรักษา ทั้งในสหรัฐอเมริกา และ ทั่วโลก (Steelman, 2015)

มโนทัศน์ทางการพยาบาลปริศัลยกรรม

- ➡ ความหมายของ **Perioperative RN** พยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาลปริศัลยกรรม เป็นพยาบาลที่มีการใช้กระบวนการพยาบาลในการพัฒนาการวางแผนการดูแลผู้ป่วยแต่ละคน และประสานความร่วมมือและให้การดูแลผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัดหรือหัตถการที่มีการล้วงลำเข้าสู่ร่างกาย จำเป็นต้องวินิจฉัยความต้องการของผู้ป่วย ตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้ป่วย ให้การพยาบาลและกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุผลลัพธ์สูงสุดสำหรับผู้ป่วย (AORN, 2018)

- 
- 1) ตอบสนองทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมวัฒนธรรม และจิตวิญญาณของ
ผู้ป่วยตลอดกระบวนการ ต้องสามารถ (AORN, 2017)
 - 2) ใช้มาตรฐาน ความรู้ การตัดสินใจ และทักษะบนพื้นฐานของหลักการทาง
วิทยาศาสตร์
 - 3) เป็นผู้มีจริยธรรม ความรับผิดชอบ และร่วมรับผิดชอบ สำหรับคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย
 - 4) เป็นผู้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นฐานในการปฏิบัติการพยาบาล
 - 5) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความหมายของการปฏิบัติการพยาบาลปริศัลยกรรม สอดคล้องกับ ความหมายของการพยาบาลโดย ANA ที่ให้ความหมายว่า

- การพยาบาลคือการป้องกัน การส่งเสริม และ การเพิ่มประสิทธิภาพของความสามารถและภาวะสุขภาพ การป้องกันการบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย บรรเทาความทุกข์ทรมานจากการวินิจฉัยโรค และการรักษาตามการตอบสนองของบุคคล และการดูแลแต่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และประชาชน
- การพยาบาลปริศัลยกรรม เป็นการพยาบาลบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในการดูแลแบบองค์รวม ที่ช่วยส่งเสริมภาวะสุขภาพ และการฟื้นหายขึ้นกับประสบการณ์ของบุคคล
- การพยาบาลปริศัลยกรรม จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยความร่วมมือระหว่างทีมสหสาขาและการใช้แหล่งประโยชน์ที่เหมาะสม
- พยาบาลที่ปฏิบัติงานการพยาบาลปริศัลยกรรม จะใช้แนวทางปฏิบัติของ AORN เป็นแนวทางในการปฏิบัติและการเตรียมความรู้ที่เฉพาะ

ความหมายของการปฏิบัติการพยาบาลปริศัลยกรรม สอดคล้องกับ
ความหมายของการพยาบาลโดย **ANA** ที่ให้ความหมายว่า

- ขอบเขตของการพยาบาลปริศัลยกรรม โดยจะให้การดูแลในการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นเมื่อผู้ป่วยเริ่มได้รับการบอกว่าเขาจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด หรือกระบวนการรักษาหรือหัตถการที่มีการล้วงล้ำเข้าสู่ร่างกาย และสิ้นสุดเมื่อเขาสามารถกลับไปปฏิบัติบทบาทและความรับผิดชอบตามปกติได้ มุ่งการดูแลที่ผู้ป่วย และผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

แนวคิดทฤษฎีในการพยาบาลปริศัลยกรรม

- รูปแบบการพยาบาลปริศัลยกรรมที่เน้นผู้ป่วยเป็นสำคัญ
(Perioperative Patient Focused Model)
- รูปแบบการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน (The Transitional Care Model: TCM)
- รูปแบบเชิงระบบตามสถานการณ์ (Systems in Contingency Model)
- การพยาบาลปริศัลยกรรมบนพื้นฐานของหลักฐานมูลเชิงประจักษ์
(Evidence-based perioperative practice)

รูปแบบการพยาบาลปริศัลยกรรมที่เน้นผู้ป่วยเป็นสำคัญ (Perioperative Patient Focused Model)

- เป็นรูปแบบที่พัฒนาโดย AORN (Association of periOperative Registered Nurses:AORN) เป็นกรอบแนวคิด สำหรับการปฏิบัติการพยาบาลปริศัลยกรรม (Perioperative Nursing Practice) และฐานข้อมูลสำหรับการพยาบาลปริศัลยกรรม (Perioperative Nursing Data Set: PNDS)
- อธิบายถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย และ การพยาบาลปริศัลยกรรมที่ได้รับจากพยาบาลที่ปฏิบัติงาน (Perioperative RN)
- ประกอบด้วย การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Interventions) และ ผลลัพธ์ของการพยาบาล (Nursing Outcomes) โดยทั้งหมดนี้ มีความสัมพันธ์กับระบบสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง
- มี ผู้ป่วย เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติการพยาบาลปริศัลยกรรม

รูปแบบการพยาบาลปริศัลยกรรมที่เน้นผู้ป่วยเป็นสำคัญ (Perioperative Patient Focused Model)

รูปแบบนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1-3 จะเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยมี หลักการที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยทางปริศัลยกรรม ประกอบด้วย

- 1) ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety)
- 2) การตอบสนองทางด้านร่างกายผู้ป่วยต่อการผ่าตัด หรือหัตถการที่มีการล่วงล้ำเข้าสู่ร่างกาย (Patient physiologic responses to operative and other invasive procedures)
- 3) การตอบสนองทางพฤติกรรมของผู้ป่วย และบุคคลที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้กำหนดไว้ ต่อการผ่าตัดและหัตถการที่มีการล่วงล้ำเข้าสู่ร่างกาย (patient and designated support persons behavioral responses to operative and other invasive procedures) และ

ส่วนที่ 4 จะเป็นระบบสุขภาพ ที่มีการให้การพยาบาลปริศัลยกรรม (Perioperative Care) ระบบสุขภาพจะคำนึงถึงระบบการจัดการ และองค์ประกอบของโครงสร้างที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดูแลที่ประสบผลสำเร็จ ผลลัพธ์ของการดูแลจะเน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้ป่วย

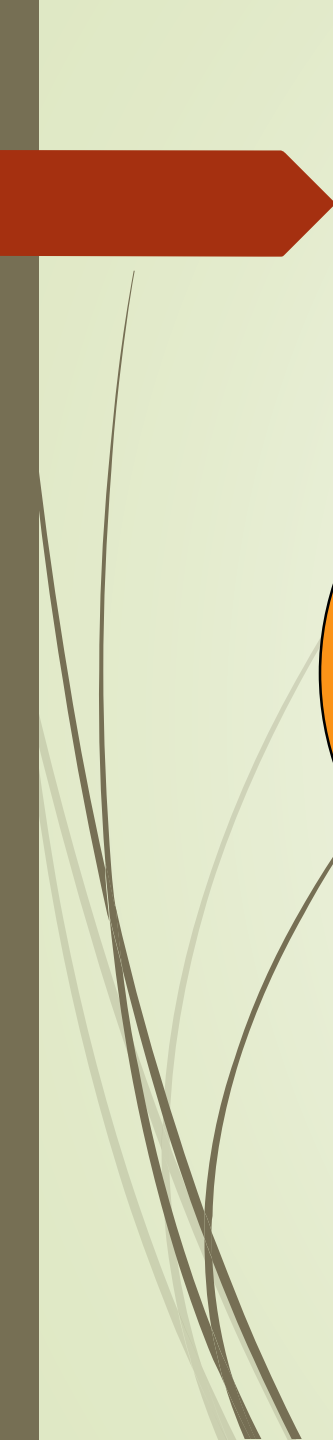
รูปแบบการพยาบาลปริศัลยกรรมที่เน้นผู้ป่วยเป็นสำคัญ (Perioperative Patient Focused Model)

เป้าหมายของการปฏิบัติการพยาบาลปริศัลยกรรม คือการช่วยผู้ป่วยและบุคคลที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้บรรลุถึงความสุขสบายในระดับเท่ากับหรือมากกว่าที่ผู้ป่วยมีก่อนการผ่าตัด และหัตถการที่มีการล้วงลำเข้าสู่ร่างกาย

สถานที่สำหรับการปฏิบัติการพยาบาลปริศัลยกรรม (Settings of Perioperative Nursing Practice) ได้แก่ ห้องผ่าตัด หน่วยผ่าตัดแบบวันเดียว หรือ แบบไม่พักค้างคืน หรือแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory surgery centers) ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ Cardiac catheterization suites, endoscopy suites, radiology departments และ หน่วยอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจมีการผ่าตัด หรือ กระบวนการรักษาหรือหัตถการที่มีการล้วงลำเข้าสู่ร่างกาย เกิดขึ้นได้

การพยาบาลปริศัลยกรรมบนพื้นฐานของหลักฐานมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-based perioperative practice)

- การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ พยาบาลควรปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลทางวิทยาศาสตร์ หรือผลงานวิจัยที่ได้มีการพิสูจน์หรือศึกษามาแล้ว มิใช่ความเห็นส่วนตัว หรือกล่าวอ้างให้ปฏิบัติโดยขาดหลักฐานที่เชื่อถือได้ เพื่อปกป้องผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจากอันตราย หรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้น



Evidence Based Practice

Evidence-based practice

- หมายถึง การกระทำ/ปฏิบัติสิ่งที่ถูกอย่าง “**ถูกต้อง**”
ความหมายนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการปฏิบัติที่ให้
ประสิทธิผลมากกว่าหรือตามมาตรฐานเท่านั้น แต่
จำเป็นต้องเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นๆ **ส่งผลดี (ประโยชน์)**
มากกว่าผลเสีย (อันตราย) (Muir Gray, 1997)
- หมายถึง การใช้**ผลของการวิจัย**ต่างๆ จากงานศึกษาวิจัย
ทางคลินิก หรือการศึกษาวิจัยแบบทดลอง เพื่อประเมิน
การปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ
(Gerrish & Clayton, 1998)

Evidence-based practice

- หมายถึง การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย การสืบค้นหลักฐาน ข้อมูลย้อนหลังหรือในปัจจุบัน ข้อมูลความเสี่ยง และการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อ พยาธิสรีรภาพ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อประสิทธิผล ความเชี่ยวชาญในทางคลินิก และ ความพอใจของผู้ป่วย

(Goode & Predalue, 1999)

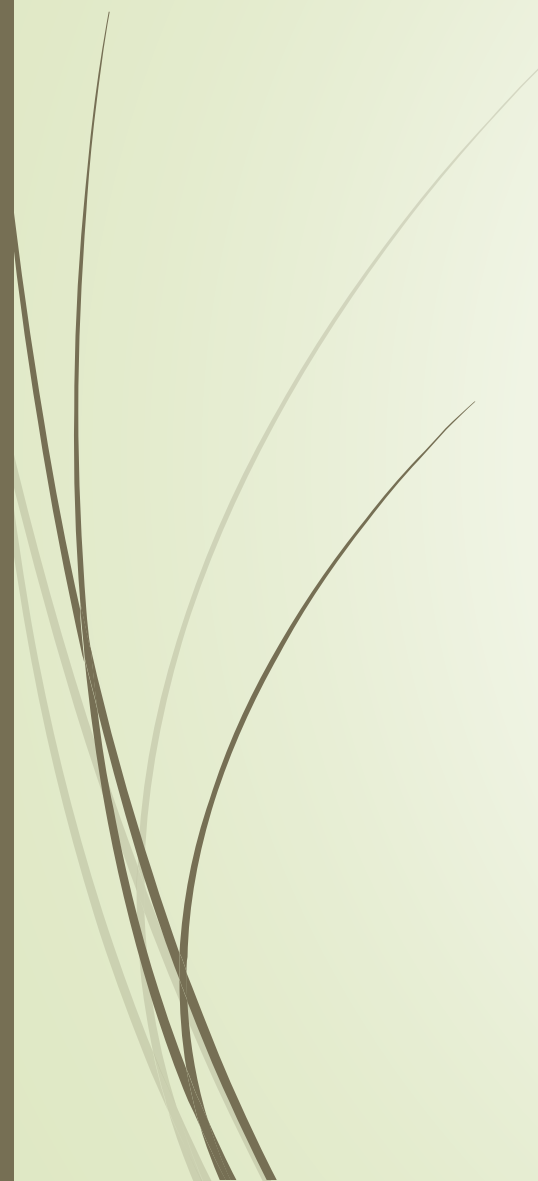
- หมายถึง เป็นการใช้อยู่ข้อมูลที่มีพื้นฐานจากการวิจัย และทฤษฎี ร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และพิจารณาถึงความต้องการส่วนบุคคล และความพึงพอใจ

ลำดับชั้นของความสำคัญของ
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากแหล่งต่างๆ

- I Systemic review of all relevant randomized controlled trails**
- II One properly-designed randomized controlled trail**
- III-1 Well designed pseudo-randomized controlled trails**
- III-2 Comparative studies with concurrent controls and allocation not randomized, Case-control analytic studies, or interrupted time series with a control group**
- III-3 Comparative studies with historical control, two or more single-arm studies, or interrupted time series without a parallel control group**
- IV Case series, either post-test or pre-test and post-test**

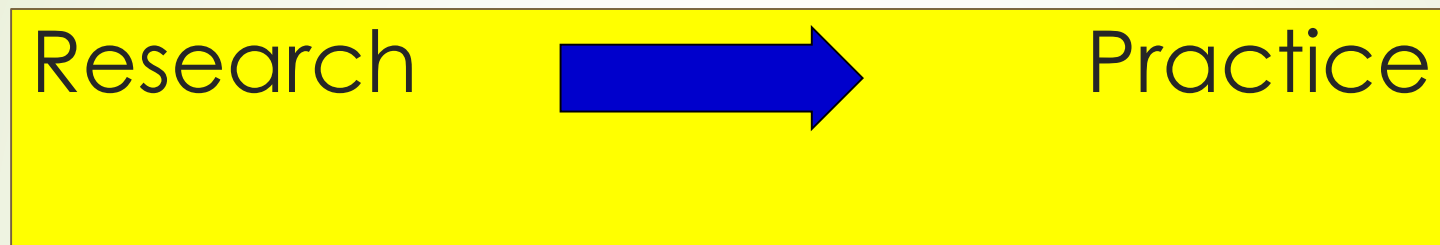


Outcome ผลของการดูแลที่เราต้องการ

- ➡ คุณภาพของการดูแล
 - ➡ ค่าใช้จ่ายต่อประสิทธิผล
 - ➡ ความพึงพอใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ ผู้จ่าย
- 

พยาบาลห้องผ่าตัดสามารถที่จะเริ่มกระบวนการของการใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยการตั้งคำถามง่ายๆ ได้แก่

- ➡ ใครควรพิจารณาการปฏิบัติหรือการรักษานั้นๆ
- ➡ อะไรคือเหตุผลสำหรับการตัดสินใจนั้นๆ
- ➡ อะไรคือแนวทางการปฏิบัตินั้นๆ
- ➡ ทำไมเราถึงได้ปฏิบัติวิธีนี้ และทำไมเราถึงได้เลือกกระทำวิธีนี้
- ➡ วิธีการรักษาหรือปฏิบัตินั้นๆ สามารถเลือกวิธีทำได้ดีกว่านี้ไหม
หรือได้ประสิทธิผลที่มากกว่า หรือค่าใช้จ่ายต่อประสิทธิผลที่
ดีกว่านี้หรือไม่
- ➡ นี่คือประสิทธิผลที่มากที่สุดที่สามารถทำได้ใช่ไหม



Perioperative Environment

- Patients are asleep – cannot assist in error prevention
- Side verification
- High velocity environment
- Complex environment
- OR Teams are not “true team”
- Communication is a major issue
- Safety may not be a high level commitment

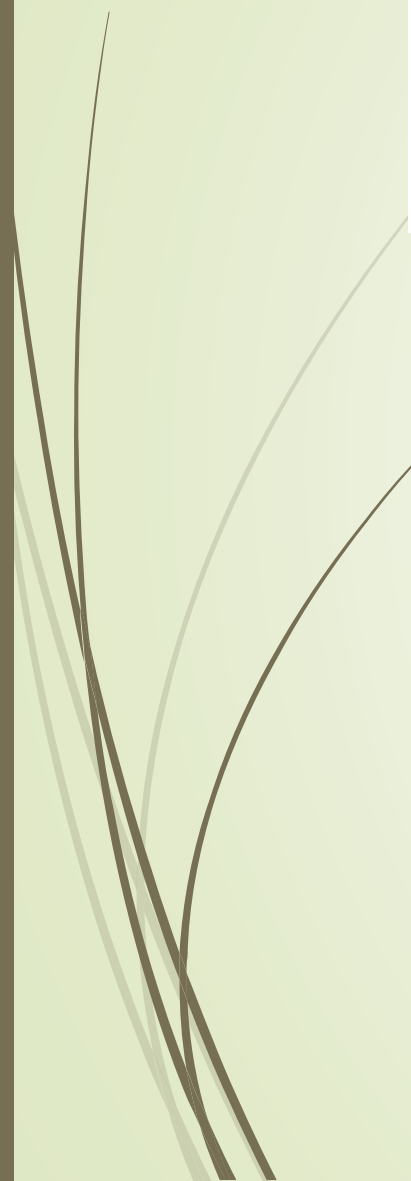


หัวใจหลักของการพยาบาลปรีศัลยกรรม

- การพัฒนาทีม
- การพัฒนาบุคลากร
- การพัฒนาความร่วมมือ
- การพัฒนาบทบาทพยาบาล
- ภาวะเครียด และการลดภาวะเครียด
- การตรวจความผิดพลาด การพักผ่อน และการป้องกัน



Nursing Concepts/ Models in Perioperative Care

- ภาวะเครียด และการลดภาวะเครียด
 - การตรวจความผิดปกติ การพักผ่อน และการป้องกัน
- 

Development of the Team

- สร้างสัมพันธ์ภาพต่อกันบ่อยๆ **Frequent interaction**
- พัฒนาให้งานน่าสนใจ **Interesting work**
- สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ **Effective communication**
- สร้างประวัติของความสำเร็จ **History of success**
- พัฒนาความสามารถในระดับสูง **High performance standards**
- ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของทีมงาน **Team members's knowledge and experience**
- การได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน **Support and encouragement from group leaders**



Collaboration

- พัฒนาวัฒนธรรมของการร่วมมือ
- สร้างทีมงาน เริ่มจากในห้องเรียน สถาบัน หน่วยงาน
- Breakfast, Luncheon meetings
- Journal Clubs
- การเที่ยวร่วมกัน
- Patient Partnerships
- Clinical collaboration



Team Roles



บทบาทชัดเจน ร่วมกัน



Clinical Pathway

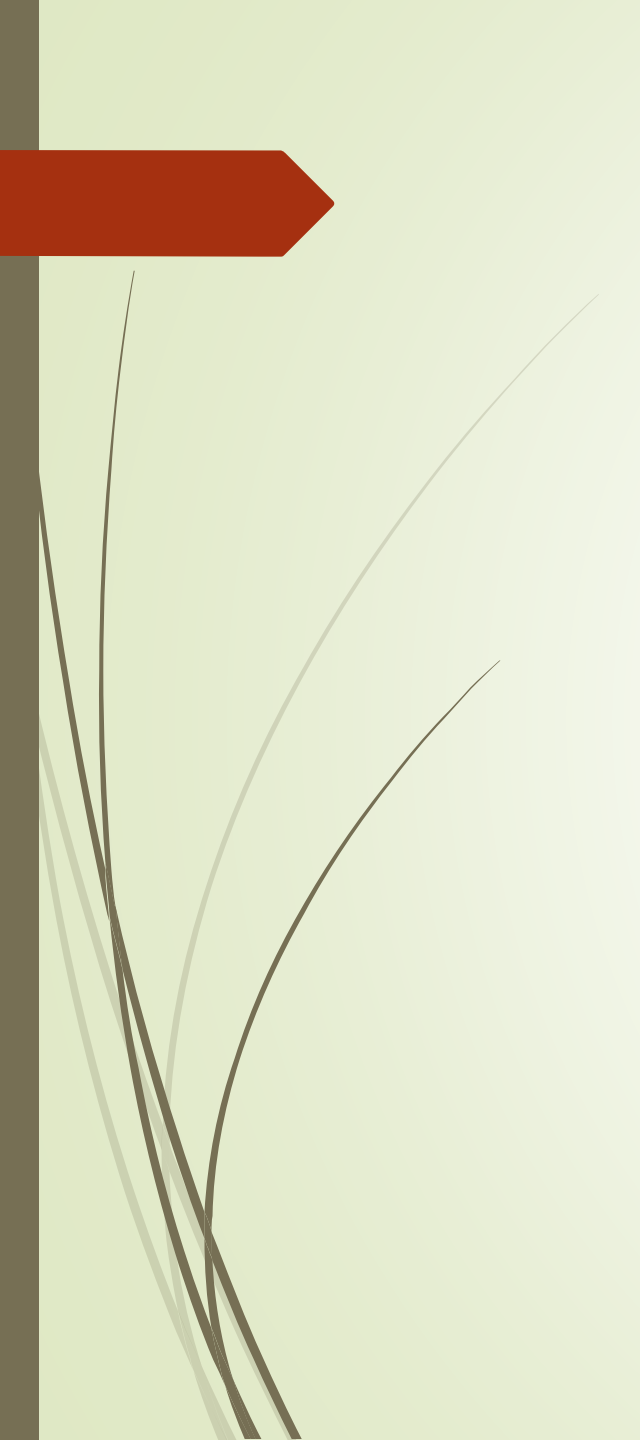
Stress and Stress Reduction

- **Avoid negative self-talk (ฉันไม่ดีเวลานี้) (ฉันไม่เคยเรียน ฉันน่าจะทำได้มากกว่านี้)**
- **Count to 10**
- **Deep breathing**
- **Exercise**
- **Humor**
- **Learn new technique**
- **Offer a break**
- **Take a brisk 15 minute walk**
- **Put your pet, family, friends on your locker door**
- **Visit a patient.... Any patient**



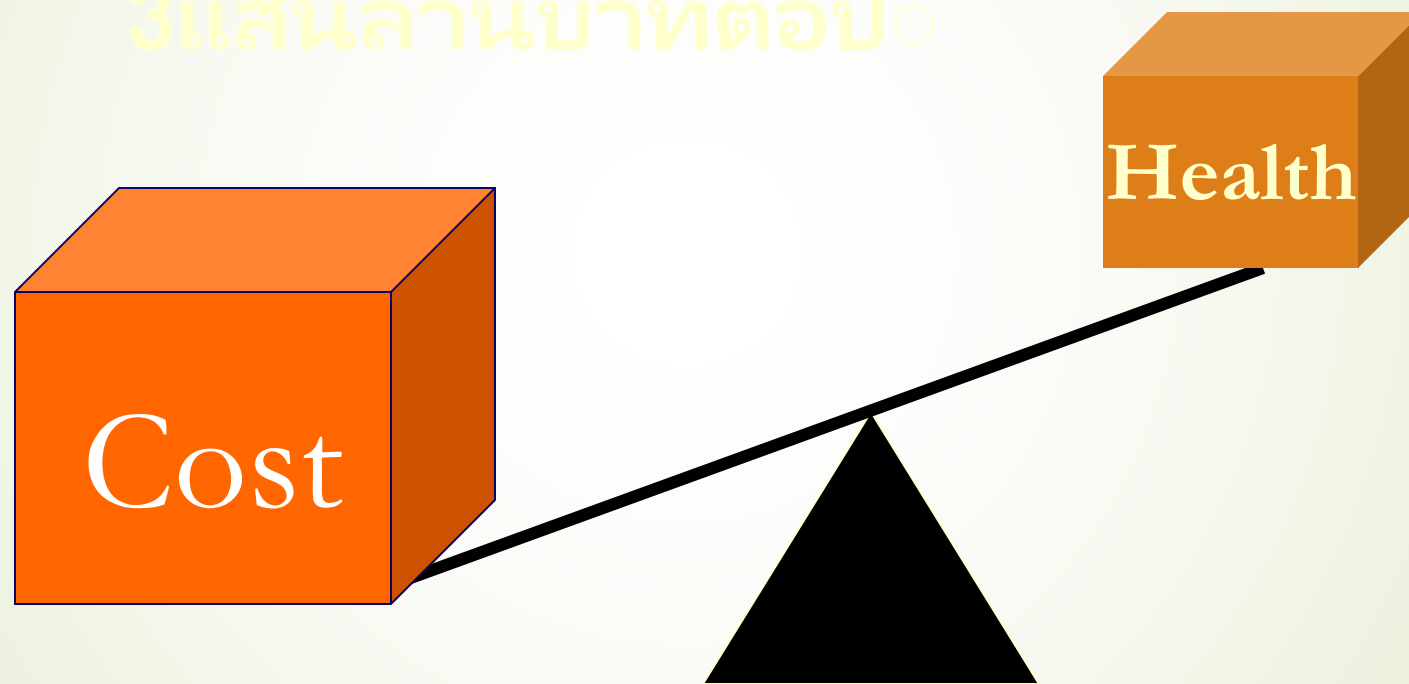
Work environment

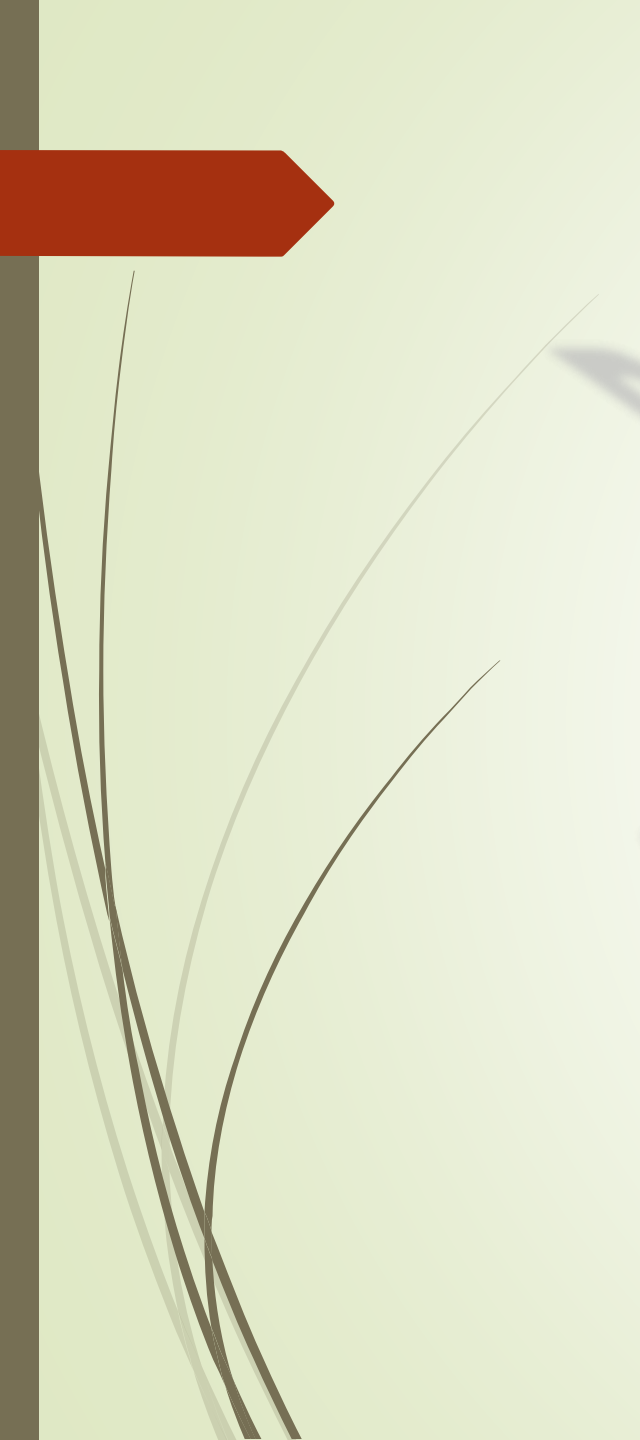
- เสียง Noise
- อุณหภูมิ Temp
- แสง Light
- อุปกรณ์ Equipment /Furniture
- สถานที่เก็บ Storage Space



Error detection, recovery, and prevention

3แสนล้านบาทต่อปี





Better Health Needs

Good Governance